

2026년 제7차 약제급여평가위원회 D+1 결과 리뷰

Leadership Brief | 2026.07.03

항목	내용
회의	2026년 제7차 약제급여평가위원회
회의일	2026년 7월 2일
보고 대상	보험약가·Market Access Leadership
공식 확인	건강보험심사평가원 「2026년 제7차 약제급여평가위원회 심의결과 공개」
핵심 결과	결정신청 5개 품목, 위험분담계약 약제 사용범위 확대 3개 품목 모두 긍정 문구로 공개

1. Executive Snapshot

한 줄 결론: 7차 약평위는 신규 5개 품목과 RSA 사용범위 확대 3개 품목을 모두 긍정적으로 정리했으며, MSD에는 직접 품목 이슈보다 린파자 HRD 양성 난소암 유지요법 확대, 카보메틱스 post-IO RCC sequencing, 넴루비오 평가금액 수용 리스크가 더 중요한 시장 신호다.

3대 leadership implication

Implication	Leadership take-away
항암 RSA 확대의 실무 기준이 더 구체화되고 있다	린파자와 카보메틱스는 모두 위험분담계약 약제 사용범위 확대 트랙에서 「급여 확대의 적정성이 있음」으로 공개됐다. 항암제는 신규 등재뿐 아니라 기존 RSA 품목의 indication expansion, 환자군 세분화, 기간·재정 관리가 하반기 핵심 축이다.
가격 수용 조건은 실제 등재 시점을 좌우한다	넴루비오는 5개 결정신청 품목 중 유일하게 「평가금액 이하 수용 시 급여의 적정성이 있음」으로 공개됐다. 임상 필요성 인정과 별개로 회사의 평가금액 수용 여부가 등재 가능성과 timing을 결정한다.
MSD 직접 안전 부재에도 전략적 read-through는 크다	키트루다 직접 적응증은 이번 결과표에 없었지만, 난소암 HRD 유지요법·RCC 후속치료·차기 항암 후보 대기열은 MSD의 항암제 가치입증, 재정영향 설명, 급여기준 협상 논리에 영향을 준다.

2. 공식 심의 결과: compact result table

결정신청 약제의 요양급여 적정성 심의결과

품목	성분	회사	대상·효능효과 요지	심의 결과
엑스코프리정 12.5·25·50·100·150·200mg	세노바메이트	동아에스티	기존 항뇌전증약으로 적절히 조절되지 않는 성인 부분발작 부가요법	급여의 적정성이 있음
넴루비오프릴필드펜	네몰리주맙	갈더마코리아	전신요법 대상 12세 이상 청소년·성인 중등도~중증 아토피 피부염	평가금액 이하 수용 시 급여의 적정성이 있음
스프라바토나잘스프레이	에스케타민염산염	한국안센	최소 2개 이상 경구 항우울제에 반응하지 않는 성인 치료저항성 우울증	급여의 적정성이 있음
팁소보정	이보시데닙	한국세르비에	IDH1 변이 양성, 이전 치료 경험이 있는 국소 진행성·전이성 담관암 단독요법	급여의 적정성이 있음
옥스루모주	루마시란나트륨	메디슨파마코리아	소아·성인 제1형 원발성 고옥살산뇨증 치료	급여의 적정성이 있음

위험분담계약 약제의 사용범위 확대 적정성 심의결과

품목	성분	회사	급여 확대 범위	심의 결과
카보메틱스정 20·40·60밀리그램	카보잔티닙	임센코리아	1차 치료에 실패한 전이성·재발성 투명 신세포암 단독요법	급여 확대의 적정성이 있음
크리스비타주사액 10·20·30밀리그램	부로수맙	한국교와기린	FGF23 관련 저인산혈증성 구루병 및 골연화증 성인 환자	급여 확대의 적정성이 있음
린파자정 100·150밀리그램	올라파림	한국아스트라제네카	1차 백금 기반 항암화학요법과 베바시주맙 병용투여에 반응한 HRD 양성 고도 상피성 난소암·난관암·일차 복막암 성인 환자의 병용 유지요법	급여 확대의 적정성이 있음

3. 시장·정책 시사점

첫째, 이번 결과는 “신규 품목 + 기존 RSA 품목 확대”가 동시에 진행되는 현재 약평위 운영의 전형적 모습을 보여준다. 결정신청 품목은 신경계, 피부질환, 정신건강, 담관암 표적치료, 초희귀질환까지 넓게 분포했고, RSA 확대 품목은 항암·희귀 장기치료 영역으로 구성됐다. 단일 therapeutic area 이벤트가 아니라, 고가 약제 접근성과 재정관리 장치가 여러 질환군에서 병행되는 차수로 해석해야 한다.

둘째, HIRA 공개 문구는 임상적 필요성과 가격·재정 불확실성을 분리해 보여준다. 넴루비오의 조건부 문구는 “평가금액 이하”를 수용해야 한다는 가격 discipline을 분명히 한다. 반대로 엑스코프리·스프라바토·팁소보·옥스루모는 공식 표에서 별도 가격수용 조건이 드러나지 않았다. 이 차이는 이후 NHIS 협상, 고시 시점, 실제 접근성에서 품목별 리스크 차이로 나타날 수 있다.

셋째, 항암제는 ‘새 약제 진입’보다 ‘세부 환자군·치료순서·유지기간’ 관리가 더 중요해지고 있다. 린파자는 HRD 양성, 백금·베바시주맙 반응, 병용 유지요법이라는 다중 조건으로 환자군이 정의된다. 카보메틱스는 1차 치료 실패 이후의 전이성·재발성 투명 신세포암 단독요법이다. 두 사례 모두 전체 암종 접근보다 biomarker, line of therapy, prior regimen, duration management를 명확히

하는 방식으로 재정영향을 통제한다.

넷째, 이번 차수는 희귀·정신건강·피부질환까지 포함한 **broad access signal**이다. 옥스루모와 크리스비타는 환자 규모가 제한적이지만 장기 치료와 **lifetime burden**이 큰 영역이고, 스프라바토는 투여·관찰 인프라가 필요한 치료저항성 우울증 약제다. HIRA가 질환 부담과 관리 가능성을 함께 보면서 접근성 확대를 검토한다는 점은 향후 MSD 비항암 포트폴리오에서도 참고할 만하다. 다만 약평위 결과만으로 실제 급여기준, 환자 본인부담, 시행일을 단정해서는 안 된다.

4. MSD 영향: direct issue는 없지만, read-through는 세 가지

4.1 린파자: HRD/biomarker maintenance BIA와 기간관리 선례

림파자 확대는 MSD 품목은 아니지만, 항암제 재정영향 논리에는 의미가 크다. HRD 양성으로 환자군을 좁히고, 1차 백금 기반 항암화학요법과 베바시주맙 병용에 반응한 환자에 한정하며, 이후 병용 유지요법으로 정의했다. 이는 고가 항암제의 budget impact를 설명할 때 **biomarker prevalence, 검사 기반 선별, prior response, 유지요법 기간, 중단 기준**을 함께 제시해야 한다는 메시지다.

MSD 관점에서는 키트루다 자체 적응증과 직접 충돌하지 않더라도, 향후 항암제 확대 논의에서 “longer duration but narrower eligible population” 구조를 어떻게 설명할지가 중요하다. 특히 난소암·부인암 영역에서 FRα, HRD, BRCA, PD-L1 등 biomarker-defined segment가 늘어나는 만큼, 환자 수 산정과 기간관리 가정의 투명성이 leadership discussion의 핵심이 된다.

4.2 카보메티스: post-IO RCC sequencing과 real-world pathway 관리

카보메티스 확대는 RCC에서 1차 치료 이후 sequencing을 다시 보게 만드는 신호다. 국내 RCC 환경은 면역항암제 병용, TKI, 후속 단독요법이 line별로 연결되기 때문에, 1차 치료 실패 후 어떤 환자가 카보잔티닙으로 이동하는지가 실제 재정영향과 처방 흐름을 좌우한다.

MSD는 키트루다 기반 RCC 치료전략과 후속 TKI 사용 가능성을 함께 모니터링해야 한다. 고시 세부기준에서 prior IO, prior TKI, clear-cell 정의, 재발성·전이성 범위, line 제한이 어떻게 표현되는지에 따라 1차 면역항암제의 value story와 후속치료 pathway 설명이 달라질 수 있다.

4.3 넴루비오: 평가금액 수용 리스크의 재확인

넴루비오는 이번 차수의 유일한 「평가금액 이하 수용 시 급여의 적정성이 있음」 품목이다. 이는 atopic dermatitis 영역의 제품 이슈를 넘어, 높은 unmet need가 있어도 HIRA 평가금액과 회사 기대가격 사이의 간극이 남으면 실제 등재가 지연될 수 있다는 점을 보여준다.

MSD 포트폴리오 관점에서는 launch planning 단계에서 “임상 가치 인정”과 “가격 수용 가능성”을 별도 gate로 관리해야 한다. 특히 환자 수가 넓거나 장기 투여가 예상되는 면역·염증성 질환에서는 평가금액 수용 여부, 대체약제 가격, 환자 본인부담 구조, 단계적 급여기준이 등재 시나리오를 좌우한다.

5. Next watchlist

후보	현재 의미	MSD 관찰 포인트
사이람자	1월 암질심 이후 약평위 결과표 미확인 상태가 지속되는 항암 확대 후보	위암 후속치료·병용 포지셔닝, 장기 대기 후 상정 시 가격·재정관리 메시지 확인
옵디보 + 여보이	4월 암질심에서 간세포암 1차 설정, 약평위 후속 확인 필요	IO-IO combination이 HCC 1차에서 어떤 가격·급여기준 논리로 정리되는지 확인
엘라히어	5월 암질심 이후 난소암 FRα 양성 후보	림파자 HRD 사례와 함께 부인암 biomarker segmentation 및 BIA logic 비교
버제니오	5월 암질심 이후 HR+/HER2- 조기 유방암 보조요법 후보	조기암 장기 투여·재발위험 선별·adjuvant budget impact 설명 방식 확인
림카토주	국산 CAR-T 재논의 가능성 모니터링	희귀·첨단재생 고가 치료제의 근거성속도와 위험분담 구조 관찰

6. Leadership actions

1. **고시 세부기준 확인:** 린파자와 카보메텍스는 약평위 문구만으로 실제 사용범위를 확정하지 말고, 후속 고시에서 line, biomarker, prior regimen, duration, 중단 기준을 확인한다.
2. **BIA template 업데이트:** 항암 유지요법과 post-IO sequencing 사례를 반영해 patient funnel, eligible population, treatment duration, discontinuation assumptions를 분리한다.
3. **차기 약평위 후보 업데이트:** 사이람자, 옴디보+여보이, 엘라히어, 버제니오를 8차 이후 watchlist에 유지하고, 암질심→약평위 전환 기간이 길어지는 품목은 별도 escalation 대상으로 둔다.
4. **가격수용 gate 점검:** 넘루비오 사례를 launch readiness checklist에 반영해 평가금액 수용 가능성, comparator price, 환자 규모, 단계적 급여기준을 조기 점검한다.

7. 출처 및 해석 범위

본 brief의 공식 사실은 건강보험심사평가원이 공개한 「2026년 제7차 약제급여평가위원회 심의결과 공개」의 품목명, 회사명, 효능·효과 또는 급여 확대 범위, 심의 결과 문구에 근거한다. 시장·정책 시사점과 MSD 영향은 해당 공식 결과를 바탕으로 한 Market Access 해석이며, 실제 등재 여부·약가·시행일은 약가협상, 건강보험정책심의회위원회, 보건복지부 고시 이후 확정된다.

이 문서는 공개 결과를 leadership 의사결정용으로 압축한 것이며, 비공개 환급률, 회사별 내부가격, 최종 약가 또는 특정 품목의 등재일을 추정하지 않는다. 따라서 후속 업무는 공식 고시와 세부급여기준 확인, 환자군 산정 가정 업데이트, 가격수용 여부 확인으로 분리해 진행한다.